CLINICA SAÚDECAMPINAS

LAUDO PERICIAL MÉDICO

Paciente: MARIA DA SILVA SOUZA (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA)

Data de Nascimento: 14/03/1978

Documento (CPF): 123.456.789-00

Base de informações:

Queixa principal: cefaleia e tontura há 3 meses. História da doença atual: início insidioso, sem trauma craniano prévio. Antecedentes: hipertensão arterial em uso de losartana. Exame físico: PA 14x9, freq. cardíaca 78 bpm, sem déficits.

MARIA DA SILVA SOUZA (PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA)

06/10/2026

Ao medico-perito

O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 06/10/2026 17:55:42. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 06/10/2026 17:55:42. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 06/10/2026 17:55:42. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus. O paciente compareceu à data deste exame relatando cefaleia occipital intermitente, associada a episódios de tontura postural e sensação de instabilidade ao deitar e levantar, sem sinais de déficit neurológico focal à inspeção e sem alterações de força ou tônus.

grato

Diagnóstico: CID: G43.9; R51

Conclusão Pericial:

- [X] Apto(a) para atividades laborais
- [ ] Inapto(a) temporariamente para atividades laborais
- [ ] Inapto(a) definitivamente para atividades laborais

Período sugerido de afastamento (quando aplicável):

De: **15 DIAS**

Observações Adicionais:

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 06/10/2026 17:55:42. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço,

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 06/10/2026 17:55:42. Verifique a autenticidade e integridade do documento em validar.iti.gov.br.

colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados. Paciente orientado no tempo e no espaço, colaborador durante toda a entrevista, sem indícios de simulação. Refere melhora parcial dos sintomas com repouso e piora aos esforços prolongados.

Local e Data: Campinas/SP, 06/10/2026

CLINICA SAUDE CAMPINAS

Av. Norte-Sul, 1200 - Cambuí, Campinas/SP

(19) 3252-4040

Documento emitido por Juan Marcelo Cabello Merida (CRM 161792 SP)

Verifique a assinatura digital

Código: abc123def456ghi789

Código de acesso: 4821

Dr. Juan Marcelo Cabello Mérida

CRM 161792 SP

Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por **JUAN MARCELO CABELLO MERIDA LTDA** (CNPJ 23.420.313/0001-02 - CRM 161792 SP) em 06/10/2026 17:55:42.
Verifique a autenticidade e integridade do documento em **validar.iti.gov.br**.